

脳卒中・SAHのICU管理 — 要約

解説「脳卒中・SAHのICU管理」の要点を絞った2ページ版。「詳しく」から本編へ。

聖路加国際病院 集中治療科 / 対象：研修医・専攻医・看護師 / 最終更新 2026-10-09

1 持ち帰る3点 詳しく

血圧は病型と時期で決める

脳梗塞は再灌流後も180/105以下で140未満を狙わない。脳出血は140前後で130未満にしない

脳出血は中和を並走させる

降圧と同時に、抗血栓薬の薬剤名と最終服用時刻を確かめて中和する

SAHは出血の後の連鎖に備える

24時間以内の処置・経腸ニモジピン・腰椎ドレナージ。DCIは症状で見つけて昇圧で迎える

2 血圧の目標は病型と時期で決まる 詳しく

病型・時期	目標	理由・注意
脳梗塞：溶解・EVTの前	185/110未満（溶解）、185/110以下（EVT）	再灌流までは低血圧を避ける（ペナンプラの灌流は血圧に依存）
脳梗塞：溶解・EVT後24時間	180/105以下	再灌流成功後に140未満を狙う降圧は有害（COR 3: Harm）。120未満で悪化と重度障害が増えた
脳梗塞：再灌流療法なし	220/120未満なら急いで下げない	48～72時間以内の降圧開始は転帰を変えない
脳出血：急性期	収縮期140前後、130未満にしない	8 RCT・12,669例で積極的降圧は機能予後・死亡・血腫増大を変えず。変動も作らない
SAH：処置まで	高度の高血圧は治療、急な大幅降圧は避ける	ガイドラインに数値はなく、実務では140か160未満
SAH：処置後・DCI	変動を作らない。昇圧は症候性DCIから	予防的な昇圧・hypervolemiaはしない

3 脳梗塞 — 抗血栓薬と悪性浮腫 詳しく

- 再灌流療法の適応は時計から画像へ：4.5時間以内はテネクテプラゼ0.25 mg/kgかアルテプラゼ0.9 mg/kg。EVTは画像で選べば24時間まで（DAWNで機能的自立48.6%対13.1%）。EVTの麻酔はどちらも平均血圧の低下を作らない
- 抗血栓薬：アスピリンは24～48時間以内（早期再発を約50%減らす）。緊急抗凝固はしない。心房細動のDOACは梗塞が大きいことだけで先送りしない。VTE予防はIPCから
- 溶解後の症候性出血：溶解薬を止め、クリオプレシピテート10単位でフィブリノゲン150以上、トラネキサム酸1,000 mgを10分で
- 悪性MCA梗塞は悪化する前に外科を呼ぶ日を決める：60歳未満・48時間以内の減圧開頭で12か月死亡71%→22%。高齢では生存が重い障害を伴いうることを事前に話す

4 脳出血 — 140前後で止め、薬剤別に中和する

[詳しく](#)

抗血栓薬	中和	注意
Xa阻害薬	4F-PCC（アンデキサネットより優先）	至適用量は未確定。国内では適応外
ダビガトラン	イダルシズマブ5 g	ダビガトランにしか効かない。薬剤名を確定する
ワルファリン	ビタミンK 10 mg+PCC	ビタミンK単独は効き始めが遅い
ヘパリン	プロタミン	低分子量ヘパリンは約60%しか中和されない
抗血小板薬	血小板輸血はしない	PATCHで不良機能予後OR 2.04。アスピリン内服で開頭血腫除去をするときだけ

抗凝固の再開は中和の時点で計画に入れる（心房細動合併では発症7～8週間後が候補）。

5 SAH — 24時間以内に処置し、DCIは症状で見つける

[詳しく](#)

再出血（未処置で約12%、大半が24時間以内）→ EBI（72時間以内）→ DCI（20～30%、第4～14病日）の1本の連鎖

備える

- 24時間以内に処置して完全閉塞。トラネキサム酸はルーチンに使わない
- 経腸ニモジピンを第4～14病日まで途切れさせない（本邦未承認）
- 腰椎ドレナージ（EARLYDRAIN：不良転帰45%→33%、NNT 8.3）

見つけて迎える

- DCIは攣縮の別名ではない。新しい局所症状かGCS 2点以上の低下で診断
- TCDは特異度97%・感度66%。陽性なら動き、陰性で安心しない
- 他の原因を除き、心機能を確認めて昇圧+euolemia。予防的triple-Hと水制限はしない

- EVDは毎時クランプして実値を読み、早めに離脱する。けいれんの予防投与はルーチンにせず、使うならレベチラセタムで3日まで（フェニトインはニモジピンを分解する）
- 全身合併症は最大60%：心筋障害（昇圧の前に心機能）・肺水腫・低Na・発熱を後回しにしない

6 共通のICUケアと転帰の語り方

[詳しく](#)

- 二次性侵襲を毎日潰す：低酸素ならSpO₂ 94%超、PaCO₂ 35～45、発熱は正常体温へ、血糖140～180（80～130の厳格管理はしない）、等張晶質液
- 嚥下は24時間以内に評価。抜管はGCSではなく気道防御で。離床は早く、発症24時間以内の高用量は避ける
- 「良好」と「治った」は別：SAHの1年で71%に認知障害、mRS 0～2でもほぼ半数。改善は4年続きうることも同じ重みで伝える

☐ EVT後に140未満へ下げない

☐ 降圧だけで脳出血を止めようとしらない

☐ 薬剤名を確かめてから中和薬を出す

☐ TCD陰性でDCIを否定しない

出典：本編の主要文献（AHA/ASA 急性虚血性脳卒中 2026；AHA/ASA 動脈瘤性SAH 2023；J-NCCG 2024；NCS・SCCM 抗血栓薬関連頭蓋内出血 2026；Semione CCM 2026；Busl Crit Care 2025；Smith ICM 2019；DAWN NEJM 2018；SHINE JAMA 2019 ほか）。用量・設定は教育目的の記載で、使う前に原著・添付文書・各施設の基準と照合してください。